

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SESION EXTRAORDINARIA
37-2023

Sesión extraordinaria número 37-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tukurrique, al ser las dieciséis horas del 16 de mayo del dos mil veintitrés. Con la asistencia de los señores (as):

- Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.
- Concejales Propietarios:** Andrea Sánchez Vega, Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Héctor Agüero Luna, Mario Moya Sánchez.
- Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes y Martín Salas Casasola.
- Intendente:** Wilberth Quirós Palma.
- Vice Intendenta Municipal:** Rocío Portuguesez Araya.
- Ausencias justificadas:**
 - Liz Amadelys Morales Rodríguez – Motivos de salud.
 - Héctor Agüero Luna – Motivos Laborales.
 - Cristopher Sánchez Corrales – Motivos Laborales.
- Ausencias injustificadas:** No hubo.
- Secretaria:** Hazel Saborío Calderón

Articulo I.
Orden del Día

- Artículo I. Orden del día
- Artículo II. Apertura de la Sesión
- Artículo III. Comprobación del quórum
- Articulo IV. Capitulo Único
- Artículo V. Acuerdos
- Artículo VI. Cierre de sesión

Articulo II
Apertura de la sesión

1 El señor Vindas Ureña, Presidente Municipal en ejercicio, da los buenos días a los presentes;
2 luego da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en
3 forma unánime.

4 **Artículo III.**

5 **Comprobación de quórum**

6 El señor Vindas, Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
7 determina que el mismo está completo, asimismo, manifiesta que esta sesión fue convocada
8 con el punto único de recibir a la Directora del Hospital William Allen Taylor la cual va a exponer
9 asuntos relacionados al traslado del nuevo hospital William Allen Taylor.

10

11 **Artículo IV.**

12 **Capítulo Único**

13 El señor Presidente da la bienvenida y manifiesta que esta sesión fue convocada como lo
14 manifestó anteriormente tiene como objetivo de exponer asuntos relacionados al traslado del
15 nuevo hospital William Allen Taylor por parte de la señora María José Solano Fallas Directora
16 del Hospital, Lidieth Castro Solano Directora Administrativa y el señor Jeison Sánchez equipo
17 de apoyo.

18 La señora María José Solano Fallas Directora del Hospital agradece y enfatiza que es un gusto
19 ser atendido por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique e indica que trae la noticia que
20 para ella y muchos es un sueño hecho realidad que es el Traslado al nuevo Hospital, el Hospital
21 William Allen Taylor tiene 96 años de historia de ser el primer hospital en el primer cantón del
22 país, primero estuvo el San Juan de Dios llamado Policlínico; el HWAT fue creado por la
23 necesidad por una familia que tuvo a un hijo William Allen Taylor que fue un muchacho que
24 fue herido de bala y se trasladó en condición grave de Turrialba hasta San José y de camino
25 falleció y como gesto de solidaridad su familia donó su casa de madera de dos cuartos para
26 que un área de salud utilizara como hospital ya que en la zona no se contaba con un hospital
27 cerca y era requerido por la población, y en ese momento habían muchas enfermedades
28 tropicales las cuales afectaban a la población.

1 Del HWAT nace el modelo de la caja un modelo tripartito donde el patrono y el trabajador
2 aporta, y nace por las necesidades económicas para poder comprar medicamentos, para el
3 pago de los médicos, en los libros de historia se evidencia que se le pagaban mil colones al
4 director y se le daba un caballo. El HWAT fue un hospital escuela en donde muchos
5 especialistas de Centroamérica e incluso de Europa se iban a formar al hospital y ahora es un
6 gran sueño para miles de personas que han estado detrás del proyecto del nuevo hospital que
7 hoy en día se hace realidad.

8 Se destaca que el hospital atiende al 60% de la población de la provincia de Cartago, y se
9 tiene una población que se ubica en una zona de difícil acceso como lo es el territorio indígena,
10 que deben de pensar en ellos, se atienden a 8000 personas indígenas y también se atiende a
11 migrantes. Por lo cual una de las características que tiene el hospital es que es un hospital
12 multicultural, se tiene la población indígena Cabécar, pero también se tiene otras poblaciones
13 indígenas. La connotación cultural del hospital se tomó en cuenta cuando hace más de 10
14 años se coordinó el plan funcional para definir que se necesita para cada departamento, pero
15 también se tomó en cuenta a la comunidad, en donde se fue a la comunidad indígena Chirripó
16 y se dialogó de las necesidades de la población con respecto al hospital y se tomó en cuenta
17 como en la rotulación, es un hospital inclusivo porque todos los rótulos se pueden encontrar
18 en Cabécar y en Braille, y también en la estructura del nuevo hospital tiene la connotación
19 indígena, el vestíbulo, la entrada principal tiene una forma cónica que tienen las casa indígenas
20 y las paredes que tienen hendijas entre ellas que asimila todo lo que son las verjas con espacio
21 entre ellas.

22 El nuevo hospital va a crecer aproximadamente 5 veces en infraestructura ya que el hospital
23 actual mide 8000 metros cuadrados y el hospital nuevo mide 42000 metros cuadrados. En
24 consulta externa actualmente se tienen 24 consultorios los cuales algunas de ellos se
25 comparten; en el nuevo hospital se va a contar con 28 consultorios con 13 salas de
26 procedimientos las cuales son salas totalmente completas como quirófanos, se tienen
27 actualmente 2 quirófanos y se van a tener 4 quirófanos en salas de operaciones y 1 quirófano
28 en sala de emergencias para un total de 5 quirófanos, se va a contar con 2 salas de partos
29 solamente una más porque según el comportamiento de la población se van disminuyendo, y

1 esas necesidades se hacen proyectadas en el comportamiento de la población, en
2 especialidades médicas actualmente se tienen 18 especialidades con 38 especialistas y ahora
3 se van a tener 22 especialidades con 45 especialistas, se van a tener 3 especialidades nuevas
4 (vascular periférico, urología, gastroenterología) se va a contar con 7 especialistas más para
5 que refuercen algunos servicios como cirugía general, anestesia, geriatría, medicina interna,
6 emergencias. La asignación de especialista es complicada por lo cual se van a dar 7
7 especialista este año y el otro año entra el otro grupo de 7 especialistas para reforzar
8 cardiología, dermatología, geriatría.

9 En camas de hospitalización actualmente se cuentan con 99 camas, y se van a contar con 232
10 camas, se reforzaron más las camas de tránsito, actualmente el servicio de emergencias
11 cuenta con 10 camas y va a tener 50 camas, el servicio de sala de operaciones tiene 9 camas
12 y va a tener 30 camas; hospital de día es un tipo de hospitalización en donde de 6 de la mañana
13 a 10 de la noche se interna al hospital, recibe transfusiones, se realizan procedimientos, pasa
14 todo el día recibiendo la atención y luego se va para su casa, por lo cual no ocupa una cama
15 de hospital y actualmente solo tiene una cama y va a tener 19 camas. En sala de partos hay 2
16 camas y se van a tener 9 camas, en terapia física no tiene camas y se va a tener todo un
17 modulo casi un edificio de rehabilitación, se van a desarrollar programas para personas que
18 tengan un accidente de tránsito o algún problema que queden con alguna limitación funcional,
19 en esta área pueda rehabilitarse rápido para no tener que mandarlos al CENARE, a Cartago o
20 a las listas de espera y que ese tiempo este no pierda funcionalidad y se incorpore rápido a su
21 vida cotidiana de manera adecuada y pronta.

22 El plan que se tiene para el traslado es un proceso delicado y se debe de trabajar como un
23 reloj suizo, el traslado todo gira alrededor de la persona hospitalizada, el día que se trasladen
24 a los pacientes hospitalizados el hospital nuevo tiene que estar listo y perfectamente equipado
25 y funcional para que se pasen a los pacientes y que sigan recibiendo toda la atención y
26 cuidados como los estaban recibiendo anteriormente y no se vea afectada su atención, para
27 lograr eso se tienen que hacer una serie de coordinaciones antes para que todo esté listo, el
28 traslado se va a realizar con los recursos que tiene el hospital que son 6 ambulancias, se va a
29 contar con el apoyo de ambulancias de la cruz roja y una ambulancia especializada que

1 bomberos ofrece, se espera que sea suficiente para poder hacer el traslado. Para realizar el
2 traslado también se va a tener que coordinar con otras instituciones para tener la seguridad
3 del resguardo para todo el camino y el trayecto por donde se van a trasladar, ya se han
4 realizado reuniones previas con las instituciones (tránsito, fuerza pública, bomberos, las
5 empresas de transportes) para tener todo listo. La empresa de transporte ha tenido contacto
6 con la dirección administrativa en relación a los horarios de los buses.

7 La señora Castro Solano Directora Administrativa menciona que han visto la necesidad de que
8 como gobiernos locales se gestione la posibilidad a nivel transporte público de las zonas que
9 vienen al sureste del hospital (Pavones, Tres Equis, Pejibaye, La Suiza, Tucurrique) porque
10 los buses los dejan a la orilla del Catie y de ahí es un kilómetro doscientos para llegar al
11 hospital, y para personas adultas mayores, alguna discapacidad, mujeres embarazadas es
12 muy difícil entrar hasta el hospital caminando, y es importante que se haga algún tipo de
13 gestión para ver si los buses de estas zonas puedan entrar al hospital a dejar pasajeros y luego
14 salir con la ruta normal, porque ya hay una empresa de buses que ganó la concesión pero
15 como ámbito de competencias podrían gestionar ya que les preocupa en relación a los
16 pacientes y lo complicado que va a ser al inicio. Entonces sería gestionar con las empresas de
17 transporte público. Destaca que en el sentido de caminar en temas de salud es bueno, pero
18 cuando se va a un hospital es por una dolencia y no están en las mismas condiciones.

19 La señora Solano Fallas Directora del Hospital continua que ya están en la fase de
20 comunicación a la población por medio de los gobiernos locales, líderes; el viernes se hizo una
21 actividad en zona indígena con líderes y con la asociación de desarrollo, maestros y contarles
22 porque el hospital no estaba terminado, pero ya ahora con la información el objetivo es
23 brindarla para que sean voceros. La comisión de la caja está elaborando boletines, pero aún
24 falta la fecha exacta en donde se van a trasladar el paciente, pero apenas se tenga se va a
25 enlazar por medio de redes sociales para el conocimiento de la población.

26 Se tiene una fecha muy clara que es el viernes 19 de mayo que es la entrega definitiva de la
27 entrega del hospital, entonces a partir del viernes el hospital pasa a manos de la caja y a partir
28 de la fecha se va a empezar el traslado, se propuso a las autoridades correspondientes para
29 que el 07 de junio sea la fecha del traslado de los pacientes, es una fecha tentativa aún no se

1 ha definido. A partir del sábado 20 de mayo se empezarán a pasar servicios administrativos,
2 las bodegas de papelería, destaca que se ha realizado todo un proceso para depurar mucha
3 documentación que de acuerdo a la ley se almacena por un periodo de tiempo establecido, se
4 está trabajando con el proceso de embalaje preparando todos los paquetes y tarimas, la
5 gerencia de logística de la caja va a prestar los camiones para trasladar todo el material, se
6 van a trasladar expedientes, papelería, archivos de recursos humanos y de los diferentes
7 servicios a partir del viernes; se tiene un kilómetro cuatrocientos centímetros de papelería para
8 el respectivo traslado. El lunes se empieza a trasladar los servicios administrativos del hospital,
9 ya una vez ya realizado el traslado del área administrativa que se espera que se abarque una
10 semana, la semana siguiente se va a preparar el hospital para acomodar y el personal médico
11 de enfermería va a empezar a mudar el hospital con todo lo que necesitan para empezar a
12 trabajar. Ya una vez listo ese proceso se van a empezar a realizar simulacros porque el hospital
13 es tan grande y están creciendo 5 veces de o que están acostumbrados, los servicios son muy
14 grandes, por ejemplo el servicio de emergencias que actualmente mide 500 metros cuadrados
15 ahora va a medir 7000 metros cuadrados, por lo tanto se van a realizar los simulacros para
16 que estén preparados y puedan atender una emergencia y que ellos tengan la agilidad y
17 capacidad para saber dónde están todos los equipos, los insumos, los implementos y no
18 tengan ningún tipo de problema. Los simulacros se van a realizar enlazados con el nivel central
19 en donde se van a contar con actores en donde van a caracterizar ser pacientes con algún ti
20 de accidente, una fatalidad, también se va a hacer un simulacro de un traslado en helicóptero
21 para probar el aterrizaje del helicóptero para hacer toda la dinámica de una emergencia, los
22 mismos se van a realizar en la semana del 29 de mayo.

23 Para realizar la actividad hace tres meses el personal del hospital se capacito con todos los
24 equipos que se van a utilizar, porque es un hospital 100% tecnológico, con los mejores equipos
25 y de ultima gama, por ejemplo, en la sala de operaciones todos los sistemas están en una sala
26 integrado de circuito cerrado en donde la cirugía que se realice la esté viendo un cirujano desde
27 el hospital Calderón Guardia en tiempo real y el cirujano pueda opinar y guiar desde otra parte
28 del país.

1 Destaca que el nuevo hospital es un hospital ecológico, que se encuentra ubicado en una zona
2 de montaña rodeado de zonas verdes, y que cuenta con 900 paneles solares, y además
3 recolecta el agua de lluvia para ser utilizado en sistemas de riego. Va a ser el mejor hospital
4 del país hasta el momento totalmente digital, la caja hace muchos años no inaugura un
5 hospital, pero lo está inaugurando de la mejor calidad que existe para el beneficio de toda la
6 población.

7 Lo que falta es el proceso de desaceleración en el hospital, ya que para que se pueda hacer
8 el traslado se necesita bajar la carga de trabajo porque de otra manera no se va a poder. Con
9 respecto al tema en sala de operaciones a partir del lunes y por un mes solo se van a realizar
10 operaciones de emergencias, las cirugías programadas se van a detener, y se van a utilizar
11 las modalidades alternativas como lo es el hospital de día y el hospital domiciliar, el cual
12 consiste en que un médico especialista con el equipo de enfermería se hospitaliza el paciente
13 en la casa, los funcionarios van a la casa a hacer los tratamientos correspondientes y se
14 devuelven y si necesitaran atención de nuevo el equipo se presenta y lo atiende en la casa en
15 donde se va a hospitalizar, todo ese proceso se realiza para descongestionar mayormente el
16 hospital.

17 El día del traslado que se espera que sea el 07 de junio no hay consultas abiertas, todas las
18 consultas en general se van a cerrar, y ese mismo día el hospital nuevo a las 6 de la mañana
19 empieza a funcionar en el servicio de emergencias y con sala de operaciones, pero de igual
20 manera de emergencia. Cuando las instituciones dan el aval para el día que se va a realizar el
21 traslado se les va a comunicar para que se dé el comunicado a la población. Se van a trasladar
22 primeramente a los pacientes que amanecen en el servicio de emergencias, y destaca que los
23 funcionarios que tienen el horario nocturno de ese día van a tener que trabajar bastante ya que
24 van a tener que bañar a los pacientes bien temprano para que se vallan aseados para el nuevo
25 hospital ya que van a ver muchas cámaras y muchos no van a querer estar mal presentados,
26 el traslado se tiene programado para se empiece a trasladar a las 7:30 de la mañana. Se está
27 definiendo si se les va a colocar un brazalete o sticker con el número de cama y los datos del
28 paciente para que sea de una forma muy ordenada y se coloquen en el edificio que les
29 corresponde. Se va a trabajar en tiempo real con expediente digital en donde se va a tener un

1 equipo de estadístico del hospital con el nivel central en donde se realice el cambio de cama
2 de los pacientes de manera inmediata y ya luego se enlace con todo lo que el paciente
3 necesite.

4 Para ese día se planea hacer como una fiesta en donde desde que salga el primer traslado
5 empiecen a sonar sirenas, las campanas de la iglesia y que se haga bulla en donde va la
6 caravana y el mismo equipo del hospital reciba a los pacientes de un forma cálida y
7 personalizada y lo lleven a su nuevo espacio. Se tiene como meta que a las doce de medio
8 día se haya terminado el traslado de los pacientes, con lo cual se proyectó tener 70 pacientes,
9 los cuales 50 de hospitalización y 20 de emergencias, pero puede variar pueden ser menos o
10 pueden ser más ya que eso no se puede medir eso depende de las enfermedades que se
11 presenten ese día.

12 El señor Presidente consulta sobre la capacidad que tienen los parqueos.

13 La señora Solano Fallas Directora del Hospital responde que se cuenta con 150 espacio de
14 parqueo para las personas que acudan al servicio médico y 300 espacios para los funcionarios
15 del hospital. Al respecto la semana que viene no puede haber ningún carro en la salida del
16 hospital parqueado porque se necesita que esté totalmente libre para empezar con el primer
17 traslado de papelería.

18 Indica que con respecto al traslado obligatoriamente se va a tener que desacelerar los servicios
19 por lo cual va a impactar las listas de espera, pero el 02 de mayo se envió todo un paquete de
20 proyectos para trabajar proyectos en tiempos ordinarios, que se llaman proyectos de listas de
21 espera, se espera que a finales de junio se inicien a realizar cirugías y procedimientos. Se
22 tiene pendientes 5000 ultrasonidos pendientes, 2000 ultrasonidos ginecológicos, más de 5000
23 electrocardiogramas pendientes, 5000 radiologías simples de tórax; todos esos
24 procedimientos van en un paquete que aprobó la caja para reducir las listas de esperas y
25 disminuir un poco el impacto que se va a tener con respecto al traslado.

26 Se va a iniciar consulta externa con un paciente menos por hora, ya que va a estar la empresa
27 encargada de los equipos acompañando los primeros días al personal por si el equipo tiene
28 algún problema en alguna aplicación de una vez se va a revisar y se va a corregir, por lo cual
29 se van a atrasar un poco las consultas por lo menos una semana, lo cual se espera que en el

1 transcurso de una semana el hospital empiece a trabajar con normalidad pero es un ajuste y
2 no se sabe si se valla a requerir de más días para que el personal conozcan y se familiaricen
3 con las nuevas instalaciones y equipos, e igual con los pacientes.

4 Se va a contar con mucho personal de seguridad que va a orientar a los pacientes para que
5 se pueda ubicar y llegar al servicio que le corresponda.

6 El regidor Moya consulta que ¿cómo se va al llamar el nuevo hospital?

7 La señora Solano Fallas Directora del Hospital responde que se va a llamar igual ya que
8 corresponde a un nombre histórico y fue un gesto de solidaridad de una familia que gracias a
9 la iniciativa de ellos es que se logró la creación del hospital, a pesar de la pobreza y la
10 necesidad ellos pensaron en la población y no es justo que con esa historia se vaya a cambiar
11 el nombre.

12 Se ha trabajado bajo una modalidad de líderes en donde en cada servicio hallan 4 líderes, para
13 que en el momento del traslado 2 líderes estén en el hospital nuevo y los otros 2 en el hospital
14 viejo coordinando cada uno de los traslados, y se encarguen de todo el proceso
15 correspondiente, se ha hecho un trabajo arduo para que funcione todo de la mejor manera.

16 El señor Presidente consulta si no van a realizar tipo brochure un dónde indique que se ubique
17 cada servicio del nuevo hospital para que las personas puedan ubicarse y no se pierdan.

18 La señora Solano Fallas Directora del Hospital responde que no se ha pensado, pero se
19 pensaba realizar una demarcación por colores como la tiene el hospital de niños, pero por
20 medio de la garantía que tiene por dos años del hospital no se puede tocar; pero ve la
21 posibilidad de tal vez manejar una aplicación digital en donde se pueda descargar y que los
22 pacientes puedan ubicarse. Destaca que el personal ha asistido a hacer guías al nuevo hospital
23 y han durado hasta 4 horas y son guías muy puntuales no abarcan todo el hospital.

24 Explica que muchos de los funcionarios van a tener mejores condiciones porque van a tener
25 mayor espacio para trabajar y van a dejar de trabajar en lugares limitados y hasta insalubres.

26 Por otra parte indica que en la primera planta va a tener un área familiar en donde se van a
27 contar con dos sodas, que se van a dar en convenio de préstamo, una se va a dar al
28 voluntariado que antes se llamaba las damas voluntarias, ellas con esos recursos le ayudan a
29 los pacientes hospitalizados con insumos que necesiten como pasta, jabón, paño, etc...

1 también toman en cuenta a los pacientes en fechas especiales como el día de la madre y el
2 padre, tienen una función humanitaria grande y se considera muy importante ya que buscan
3 beneficiar a los pacientes; el otro grupo que se va a encargar de la otra soda es la asociación
4 pro hospital que esta enlazada con la asociación pro albergue, en donde al frente del hospital
5 hay un terreno que pertenece al ICE y la asociación pro albergue está recibiendo una donación
6 de 5000 metros cuadrados para la construcción de un albergue el cual es de suma importancia
7 para la población que vive lejos del hospital y no pueda trasladarse hasta su casa por temas
8 de transporte o lejanía, en especial la población indígena, pero es para toda la población que
9 lo necesite, y así con los fondos que se hagan en la soda puedan cubrir los gastos para los
10 servicios que se tengan en el albergue, por lo cual consideran muy importante que se dé el
11 convenio entre esas dos áreas que se sabe que le van a sacar el provecho y todo para el
12 beneficio de la población en general. Esa zona esta acondicionado de la mejor manera con
13 mobiliario lujoso que se espera que las personas valoren y cuiden.

14 Destaca que es muy importante el papel de la traductora que tiene el hospital porque es la
15 primera traductora que la caja como país tiene y ha sido una maravilla, y que tiene que estar
16 en todas partes por lo cual se está solicitando la contratación de dos plazas más de traductores
17 porque la población indígena ocupa el 90% de los partos y pediatría está lleno de niños
18 indígenas en donde los médicos necesitan asegurar que el mensaje o indicaciones se le estén
19 dando sea entendido a la perfección; por eso se están pidiendo dos plazas más porque muchas
20 veces si se lleva un bebé indígena en traslado al hospital de niños la traductora debe
21 acompañarlos o si un paciente indígena va a la clínica oftalmológica a una cirugía solicitan que
22 los acompañe la traductora por facilidad y actualmente la traductora no da abasto por lo cual
23 es muy importante la contratación de al menos dos plazas más de traducción.

24 Se va a contar un área especial con refrigeración para cadáveres y actualmente es un gran
25 problema por el cual han tenido que pasar porque en especial cuando muere una persona
26 indígena y no se logra ubicar a la familia y tal vez el cadáver debe de entregarse en un tiempo
27 establecido se convierte en un gran problema, porque muchas de las veces la familia no se
28 puede contactar o pueden presentarse hasta el otro día, y es una injusticia que se tenga que
29 ir a enterrar un cadáver en la noche que al otro día la familia llegue a reclamar por el mismo.

1 La señora Castro Solano Directora Administrativa menciona que en ese tipo de caso han tenido
2 hasta que coordinar con el personal de ATAP indígena, con un convenio con el IMAS, la
3 sucursal y una funeraria, llevan el cadáver hasta grano de oro o el lugar en donde vive la familia
4 para que lo recojan y gracias al área especial con refrigeración con el que va a contar el hospital
5 se va a eliminar ese convenio y que se va a ahorrar el gasto que conlleva el proceso que el
6 cual costaba un aproximada de 120 mil colones por cadáver.

7 El regidor Fonseca Brenes menciona que no sabe si los indígenas aún tengan panteón porque
8 antes lo enterraban en cualquier parte, les gustaba mucho los zompoperos.

9 La señora Castro Solano Directora Administrativa responde con respecto al tema que hay algo
10 que muchas personas no conocen y se tiene un contrato con la funeraria, que en estos casos
11 se les entrega a los indígenas un féretro de metal, porque antes se les daba una caja normal
12 y la botaban de camino y se llevaban solo el cuerpo envuelto.

13 La regidora Calvo Pérez menciona que vivió una experiencia cuando estuvo en la Cruz Roja
14 en donde sacaron un indígena que en el hospital murió y ellos recogieron dinero para comprarle
15 un ataúd bien bonito, luego lo entregaron y ellos lo recibieron y sacaron el cuerpo y lo
16 envolvieron en hojas y botaron el ataúd.

17 La señora Solano Fallas Directora del Hospital continua con la explicación y menciona que
18 todo lo relacionado con el hospital nuevo va equipado 100% nuevo las camas, y todos los
19 equipos ya que la contratación se hizo llave en mano.

20 El Presidente consulta que ¿Qué va a suceder con las instalaciones del antiguo hospital?

21 La señora Castro Solano Directora Administrativa menciona que, con la situación respecto a
22 los Ebais en el centro de Turrialba, la caja no cuenta con ningún Ebais de propiedad de la
23 institución, todos son alquilados en lugares los cuales no son aptos para el servicio que dan,
24 fueron acondicionados en su momento, y la idea de la caja es acondicionar el área del hospital
25 para que se puedan trasladar los Ebais a esas instalaciones.

26 La señora Solano Fallas Directora del Hospital continuando con el equipamiento del hospital
27 nuevo va a contar con pantallas de televisión, de sonido, sistema de gestión digital para filas,
28 área de sillones equipados para que las personas que van por un servicio médico puedan
29 esperar con comodidad con cortinas de grado médico hechas con material especial

1 antibacterial, resistente a químicos, quirófanos con pantallas digitales para comunicarse con
2 otros lugares del país.

3 Para concluir la señora Solano Fallas Directora del Hospital hace mención a una frase del
4 poeta Jorge De Bravo *“Hace mucho que usamos este mismo vestido en la casa, la iglesia y en*
5 *el gobierno, nos hemos habituado tanto a usarlo que ahora nos da miedo y no nos atrevemos*
6 *a cambiarlo, como si en el cambio nos quedáramos muertos, lo importante es tirar este vestido,*
7 *encontrar uno nuevo y no dejar jamás que se nos hunda en la piel y en los huesos, porque*
8 *entonces amigos deja de ser vestido y se nos hace amo y carcelero”*, destaca que ese mensaje
9 se ha visto mucho con los funcionarios para adaptarse y trabajar el cambio, de dejar atrás
10 todo lo viejo y que siempre se tiene la posibilidad de hacer las cosas mejor, y de fortalecer las
11 debilidades de todas y el servicio que se brinda a toda la población. Por ultimo hace mención
12 que es hospital crece en un 35% en recurso humano, el cual se está en un proceso de
13 validación de plazas, porque se necesitan más de 300 plazas, pero les van a validar por tractos
14 135, que son plazas de traductores, técnicos, terapeutas, personal de enfermería, nutrición y
15 el servicio de aseo y de vigilancia el cual se da por terceros. Por lo cual son una gran fuente
16 de empleo para el cantón de Jiménez.

17 El hospital va a contar con más de 300 cámaras de video vigilancia para poder monitorear todo
18 en funcionamiento, el centro de monitoreo va a ser atendido por 15 guardas del hospital, 5 por
19 cada turno y se espera llenar paulatinamente, porque el traslado se va a hacer con el personal
20 que cuenta el hospital actualmente, se están haciendo los estudios en la gerencia medica para
21 las plazas y que la junta directiva la apruebe.

22 La señora Vice Intendente consulta ¿qué va a pasar con el mobiliario del hospital actual que
23 está muy nuevo?

24 La señora Solano Fallas Directora del Hospital menciona que se tiene cerca de 5300 activos y
25 hay mucho equipo muy reciente que donó la JPS, se han recibido peticiones de hospitales que
26 piden camas y equipos de radiología, pero ahorita se encuentran con una directriz de la caja
27 en donde indican que no se puede tocar ningún activo todavía, se presentó el plan que es
28 donar activos dentro de la caja.

El señor Intendente menciona que, ante tanta excelencia en el área de salud, no queda más que agradecer porque el hospital ha crecido increíblemente y es de festejar y sentirse orgullosos.

La señora Castro Solano Directora Administrativa hace un llamado a la población para que cuide el nuevo hospital porque es para su propio beneficio, y se valore lo que por tanto se ha luchado. Y por último agradecen la atención que como gobierno local los han atendido y solicitan que divulguen la información a la población para que sea de conocimiento.

Se adjunta presentación de la sesión:



Coordinaciones antes de Día D

TRASLADO DE HOSPITALIZADOS

- ❖ HWAT
- ❖ Cruz roja
- ❖ Bomberos

OTRAS INSTITUCIONES

- ❖ Tránsito
- ❖ Fuerza Pública
- ❖ Bomberos
- ❖ Empresa de Transporte Público
- ❖ Red de Servicios: HMP, ASTJ

COMUNICACIÓN

- ❖ Medios de prensa locales y grupos organizados
- ❖ Material informativo escrito y digital
- ❖ Asociación Indígena
- ❖ Supervisores MEP de Zona Indígena
- ❖ Área de Salud (EBAIS)
- ❖ Comisión Municipal de Emergencias

Actividades antes de Día D

TRASLADO

Traslado 2 semanas antes:

- ❖ Servicios Administrativos: UBGs y Financiero Contable (edificio arrendado).
- ❖ Bodegas (excepto stock de cada servicio): proveeduría, farmacia, mantenimiento, aseo, laboratorio, centro de equipos.
- ❖ Archivos y papelería (de todos los servicios administrativos).
- ❖ Logística del Traslado.

PREPARATIVOS

- ❖ Capacitación al personal HWAT del nuevo equipo.
- ❖ Capacitación al grupo Líder por servicio y personal de apoyo.
- ❖ Mudar el hospital (propieta) 2 semanas antes.
- ❖ Abastecimiento de insumos, stock, papelería en todos los servicios 2 semanas antes (Enfermería, Remes, Aseo, Farmacia).
- ❖ Simulacros de servicios críticos 1 semana antes (SOP, Emergencias, Sala de Partos).

DESACELERACIÓN

- ❖ SOP: 1 semana antes solo se realizan cirugías de emergencias y ambulatorias en una SOP.
- ❖ Hospitalización: disminución de ocupación hospitalaria 50% ocupación (1 semana antes)
- ❖ CE: Cierre de agendas el propio día D.
- ❖ Incluye servicios de apoyo RX, Laboratorio, Farmacia.

Día D

TRASLADO DE PACIENTES

- ❖ Para el día D (promedio 70 pacientes: 50 de hospitalización y 20 del servicio de Emergencias)
- ❖ Inicio: 7:30am primer paciente, finaliza 12md.
- ❖ Orden de Traslado por Servicio: Medicina interna, Cirugía, Pediatría, Ginecología y Maternidad, Emergencias (último servicio que concluye las operaciones en el hospital actual).
- ❖ Plan Emergencias

SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO EN NUEVA SEDE

- ❖ Servicios de Emergencias: habilitado a partir de las 6 am.
- ❖ Servicios de Apoyo (Laboratorio, Farmacia, Radiología, Nutrición): habilitados a partir de las 6am.
- ❖ SOP: atiende únicamente emergencias.
- ❖ CE: agendas cerradas
- ❖ Servicios Administrativos

Después Día D

RECUPERACIÓN DE SERVICIOS

- ❖ Regreso a la prestación de Servicios.
- ❖ Acompañamiento de las empresas para el inicio de operaciones de los equipos médicos.
- ❖ Operación al 50-75% de la capacidad de atención en la primera semana.
- ❖ A partir de la segunda semana se realiza normalización de los servicios.
- ❖ Proyecto Jornadas de Producción CE y Quirúrgicas UTE

Taller Líderes

- Gestión de Cambio
- Plan de traslado
- Funciones de los Líderes (embalaje, rutas, puntos de extracción y llegada).
- Qué puede salir mal?



PUNTOS DE EXTRACCIÓN



PUNTOS DE ENTREGA

1. Bodega de Farmacia
2. Bodega General
3. Lavandería
4. Archivo
5. Emergencias
6. Papelería general, pacientes, HDD







12 ACUERDOS

13 No hubo.

15 Artículo VI.

16 Cierre de sesión

17 Al ser las diecisiete horas con diez minutos el señor presidente da por concluida la sesión
18 municipal.

24 _____
25 JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
26 PRESIDENTE MUNICIPAL

24 _____
25 HAZEL SABORIO CALDERON
26 SECRETARIA MUNICIPAL a.i.

27 ÚLTIMA LINEA